2.后脱位的 Epstein 分型（12345 小大粉顶股）

I单纯脱位、或伴髋臼后壁小骨折片≈没有骨折

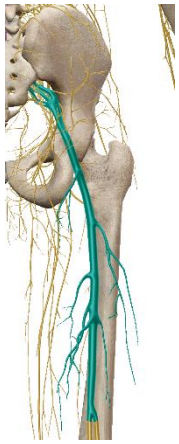
II合并髋臼后壁一大块骨折

III合并髋臼后壁粉碎性骨折

IV合并髋臼后壁和顶部骨折

V合并股骨头骨折





3.临床表现 只要是髋关节脱位就有Shenton线不连续，如发育性髋关节脱位、外伤导致的髋关节脱位、股骨头缺血坏死的IV期

①弹性固定，Shenton 线不连续（stein-shenton）

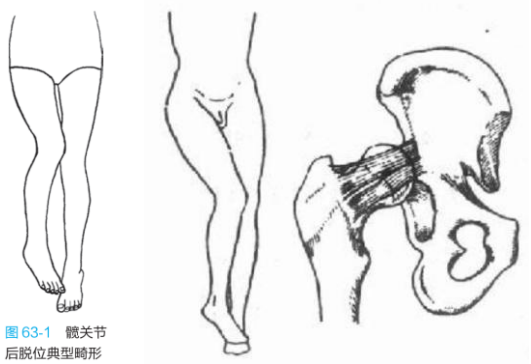
放松髋关节周围肌肉 股骨头往后上方走

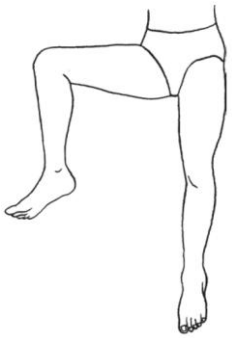
②后脱位：屈曲、内收、内旋畸形（尿急），臀部摸到股骨头，下肢缩短。可损伤坐骨神经

注意：后脱位所致神经损伤多为神经受牵拉引起的暂时性功能障碍，或是受到股骨头、髋臼骨折块的轻度挫伤，因此大多病人可在伤后逐渐恢复；若经 2-3 个月仍无恢复迹象者需手术探查

VS周围神经损伤章节:神经损伤了→及时做手术

③前脱位：屈曲、外展、外旋畸形，腹股沟摸到股骨头，下肢不定（脱衣前是外衣、脱衣后是内衣）


图 63-1 髋关节后脱位典型畸形


图 63-3 髋关节前脱位典型畸形



规律:一般是局麻
特殊:①桡骨头半脱位无需麻醉,直接复位
②髋关节脱位必须全麻或腰麻复位

4.治疗 手法复位 外固定

①后脱位 Epstein I型：Allis 提拉法+皮牵引/丁字鞋 2-3 周，24-48 小时是黄金时期，必须在全麻或腰麻下复位

（脱衣后遇到爱丽丝、让穿丁字的她给你提拉一下，丁 2 笔画） 髋关节周围的肌肉比较强大







害怕出现创伤性关节炎→追求解剖复位

②后脱位 Epstein II-V型（合并关节内骨折）、中心脱位：切开复位+内固定

	诊断	手法复位外固定		
肩关节前脱位	方肩、Dugas	H足	三角巾/搭	3w
肘关节后脱位	肘后三角改变	环抱	三角巾/长臂石膏拖	2-3w
桡骨头半脱位	<5岁、手腕↑	不用麻醉	不需要固定	
髋关节后脱位（EI）	内收内旋、shenton线x	Allis提拉	皮/丁	2-3w